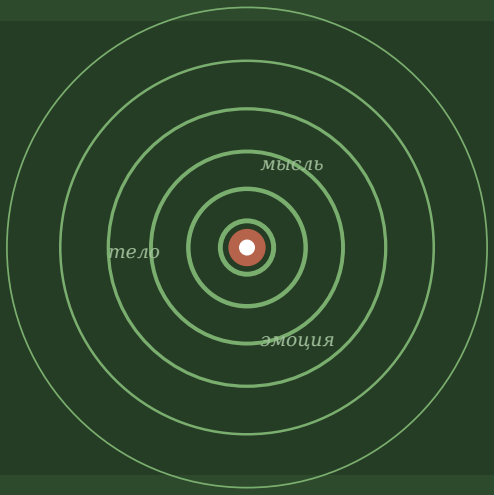
ПРАКТИЧЕСКИЙ ГАЙД ПО САМОПОМОЩИ



Самопомощь при тревоге

пошаговые техники · доказательный подход

ГОЕВА АНАСТАСИЯ

клинический психолог · КПТ · ДБТ · ЛОРП

@ogogoevaa

СОДЕРЖАНИЕ

01 **Об авторе**

02 **Для справки — что такое тревога?**

03 **Почему мы испытываем тревогу?**

04 **КПТ-модель тревоги**

05 **Тревога и мысли**

06 **Техники самопомощи**

· Дневник мыслей (АБС)

· Дерево переживаний

· Заземление 5-4-3-2-1

· Дыхательные практики

07 **Запись на консультацию**

01

Об авторе



Гоева Анастасия

Привет, меня зовут Настя — я клинический психолог, специализируюсь в когнитивно-поведенческой терапии, диалектической поведенческой терапии и личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии (ЛОРП). Я сама знаю, каково быть тревожным человеком. Поэтому собрала этот гайд: для быстрой самопомощи, основанной на доказательных методах.

Специализация	Тревожно-фобические расстройства, РПП, личностные кризисы
Подход	КПТ · ДБТ · Личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия (ЛОРП)
Запись	@ogogoevaa

02

Для справки

970 млн

человек в мире столкнулись с ментальными трудностями (данные ВОЗ)

Тревога vs Страх

СТРАХ	ТРЕВОГА
Конкретный объект угрозы	Размытая, неопределённая угроза
Возникает здесь и сейчас	Направлена в будущее: «а вдруг...»
Проходит когда угроза исчезла	Может сохраняться без видимой причины
Пропорциональна реальной угрозе	*Часто непропорционально сильная*
Пример: испугался собаки на улице	*Пример: тревога перед важной встречей*

Как проявляется тревога:

— Расстройства сна и нарушения концентрации
— Учащённое сердцебиение, дрожь, нехватка воздуха
— Сложности с регулированием эмоций
— Избегающее поведение, желание всё контролировать
— Перфекционизм и завышенные ожидания от себя
— Постоянная фоновая тревожность без видимой причины

03

Почему мы испытываем тревогу и страх?

На физиологическом уровне тревога формируется через активацию вегетативной нервной системы. Когда мозг фиксирует угрозу — реальную или воображаемую — он запускает одну из трёх автоматических реакций.

автоматические реакции нервной системы



ВСД и паника: почему тревога нарастает?

Вегето-сосудистая дистония (ВСД) — нарушение регуляции вегетативной нервной системы, которая управляет сердцем, дыханием и давлением. При хроническом стрессе система входит в режим постоянной «боевой готовности».

Когда уровень тревоги нарастает, мозг начинает интерпретировать физические ощущения (пульс, нехватку воздуха, головокружение) как сигнал опасности — и тревога превращается в панику. Это замкнутый круг.

Этот цикл можно прервать — с помощью техник, представленных в этом гайде.

КПТ-модель тревоги

Когнитивно-поведенческая терапия исходит из того, что мысли, эмоции и поведение взаимосвязаны. Изменяя мысли — меняем и реакцию.

СОБЫТИЕ	Что-то происходит вокруг или внутри нас
▼	
МЫСЛЬ	Как мы интерпретируем произошедшее (часто автоматически)
▼	
ЭМОЦИЯ	Что чувствуем в ответ на возникшую мысль
▼	
ПОВЕДЕНИЕ	Как действуем, исходя из эмоции

Примеры из практики:

Тревога перед встречей

Событие: звонок с работы. Мысль: «Меня будут критиковать». Эмоция: тревога (7/10). Поведение: откладываю, избегаю.

Социальная тревога

Событие: незнакомый посмотрел в метро. Мысль: «Со мной что-то не так». Эмоция: стыд (8/10). Поведение: ухожу, избегаю зрительного контакта.

Тревога о здоровье

Событие: учащённый пульс. Мысль: «А вдруг это сердце?». Эмоция: страх (9/10). Поведение: гуглю симптомы, паника нарастает.

05

Тревога и мысли

Мысли обладают огромной силой. Если они рисуют нас слабее других, а мир — опасным местом, они снова и снова будут запускать тревогу.

Что такое автоматические мысли?

Автоматические мысли — быстрые, непроизвольные суждения в ответ на ситуацию. Мы почти не замечаем их, но именно они формируют наши эмоциональные реакции. При тревоге они часто содержат когнитивные искажения.

Частые когнитивные искажения при тревоге:

Катастрофизация	*«Это обязательно закончится плохо»*
Чтение мыслей	*«Они думают, что я некомпетентна»*
Сверхобобщение	*«Всегда так. Никогда не получится»*
Предсказание будущего	*«Я знаю — провалюсь»*
Долженствование	*«Я должна быть идеальной»*

Как работать с мыслями:

1. Замечайте: какая мысль появилась в момент тревоги?
2. Задайте себе: насколько я верю этой мысли? (0–100%)
3. Есть ли реальные доказательства «за» и «против»?
4. Что бы я сказала подруге в такой же ситуации?
5. Какая мысль помогла бы мне чувствовать меньше тревоги?

Техники самопомощи

Четыре инструмента, которые работают прямо в момент тревоги. Каждый опирается на доказательную базу КПТ и ДБТ.

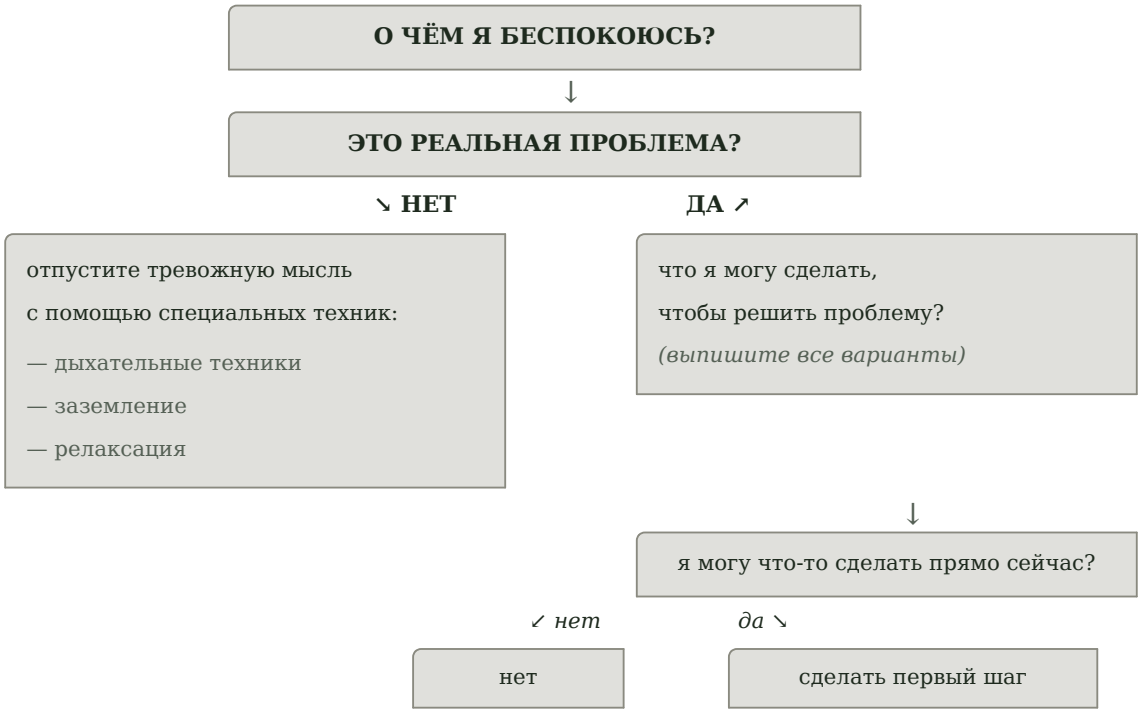
ТЕХНИКА 1 · ДНЕВНИК МЫСЛЕЙ (АБС)

Распознайте автоматическую мысль и найдите более реалистичный взгляд на ситуацию.

Ситуация	Мысль	Эмоция (0-10)	Поведение	Альтернатива

ТЕХНИКА 2 · ДЕРЕВО ПЕРЕЖИВАНИЙ

Техника помогает отделить обоснованную тревогу от мнимой и эффективно с ней справиться. Заполняйте поочерёдно каждый пункт, когда почувствуете тревогу.



**подробное описание техник для отвлечения от тревоги есть в этом гайде ниже*

ТЕХНИКА 3 · ЗАЗЕМЛЕНИЕ 5-4-3-2-1

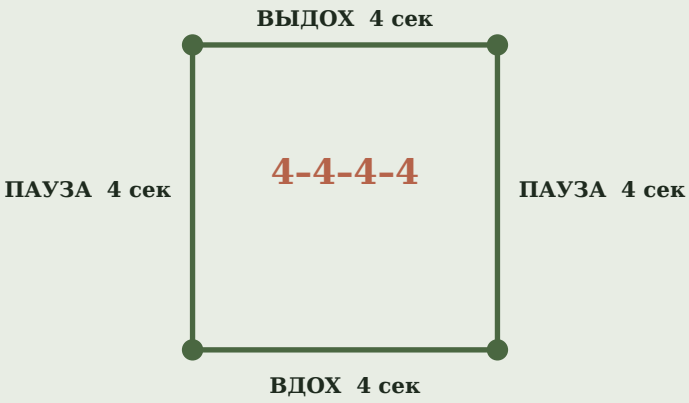
Переключает внимание с тревожных мыслей на настоящий момент через пять органов чувств.



ТЕХНИКА 4 · ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

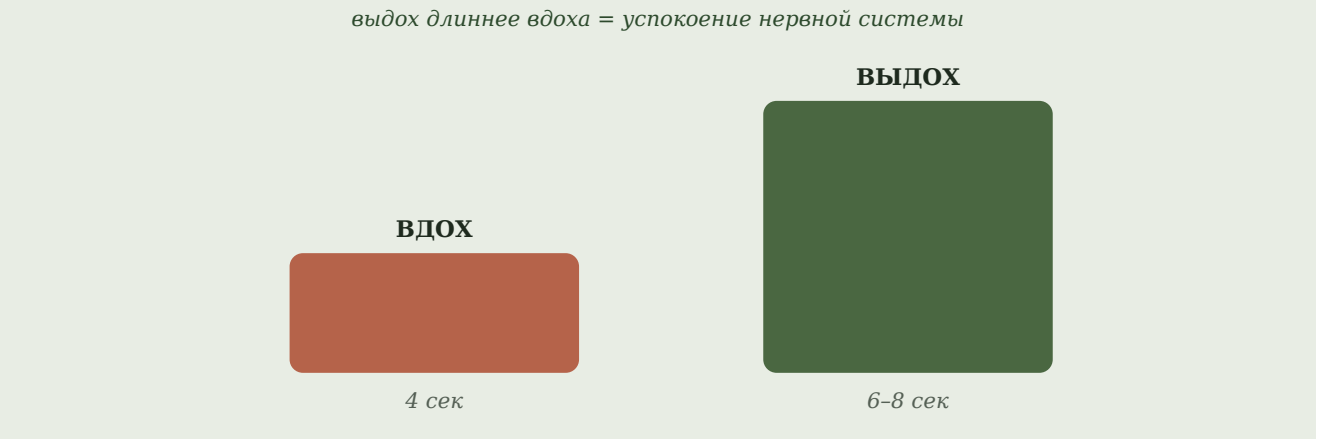
Медленный выдох активирует парасимпатическую систему — режим «отдыха и восстановления».

Дыхание по квадрату (4-4-4-4):



Если квадрат не помогает — удлините выдох:

Ключевой принцип успокоения: выдох длиннее вдоха. Вдох 4 сек → выдох 6–8 сек. Повторяйте 5–10 минут. Это сигнализирует нервной системе, что опасности нет.



Диафрагмальное дыхание:

— Положите руку на живот ниже грудной клетки
— Вдохните через нос — живот поднимается, грудь почти неподвижна
— Медленный выдох через слегка сжатые губы
— 5–10 минут в день, начать с 3 повторений

07

Готовы сделать следующий шаг?

Этот гайд — первая помощь. Если тревога стала постоянным фоном жизни и мешает работе, отношениям или сну — это сигнал поработать с ней глубже вместе со специалистом.

Запись на консультацию

@ogogoevaa

Гоева Анастасия · клинический психолог

КПТ · ДБТ · ЛОРП